

BRIEFING EJECUTIVO · RESERVADO

EsSalud: recuperación para el asegurado

Ayuda memoria de decisión para la Alta Dirección · 2026–2031

Preparado para la Presidencia de la República del Perú
Documento de trabajo reservado

1 Lo que usted decide hoy

Cinco decisiones que pueden instruirse de inmediato —dentro del marco legal vigente, sin ley del Congreso— para iniciar la recuperación de EsSalud. **Marque su instrucción con una X.**

Nº	Decisión	Instrumento	Apruebo	Observe
1	Completar el Consejo Directivo (los 9 miembros) en 30 días	Resolución Suprema + R. Ministerial (MTPE)		
2	Nombrar al Presidente Ejecutivo con mandato por resultados y metas públicas	Resolución Suprema		
3	Ordenar el tablero público de listas de espera, camas y stock (Día 30)	Resolución de Presidencia Ejecutiva		
4	Solicitar control concurrente de la Contraloría en compras oncológicas (Día 1)	Resolución PE · Ley 27785		
5	Autorizar jornadas quirúrgicas de fin de semana (primeras 10,000 cirugías)	Acuerdo de Consejo Directivo		

Las cinco no requieren ley del Congreso: se ejecutan por acto del Ejecutivo o de la propia EsSalud, con la Contraloría y SUSALUD como veedores. Solo la reforma de fondo —que el Presidente Ejecutivo sea elegido por el Consejo con mandato fijo— irá al Congreso.

2 El problema en cinco datos

12.76 M asegurados (~1 de cada 3 peruanos)	66.1% esperan +45 días una cirugía	25.9 d de diferimiento para una cita	40.5% del equipamiento crítico operativo	~10 presidentes de EsSalud 2021-2025
--	--	--	--	--

El reencuadre: no es una crisis de dinero —EsSalud cerró 2025 con superávit operativo (ingresos S/ 17,774 M) y grado de inversión (Fitch BBB)—. Es una **crisis de gobierno:** diez timoneles en cuatro años no cierran ninguna brecha. Y la reforma **no cuesta presupuesto del Tesoro:** EsSalud es contributivo (9% del trabajo formal). Fuentes: Diagnóstico MTPE nov-2025, PEI 2026-2030, RENIPRESS-SUSALUD, ComexPerú.

3 Primeros 100 días: tres victorias visibles

Victoria	Meta	Corte	Responsable
Cirugías de fin de semana y turnos noche	10,000 cirugías	Día 90	Presidencia Ejecutiva / Operaciones
Tablero ciudadano en vivo (listas, camas, stock)	Publicado y operativo	Día 30	PE / Transformación Digital
Defensoría del Asegurado con respuesta en 72 h	Operativa a nivel nacional	Día 60	PE / Defensoría del Asegurado

Cada victoria con un acto presidencial de lanzamiento y otro de corte de resultados, para fijar percepción de resultado temprano.

4 Manejo de narrativa: preguntas frecuentes

¿Es privatizar EsSalud?

No. La propiedad y la rectoría siguen siendo públicas; se contrata la **operación** de servicios (imágenes, cirugías) —modalidad ya permitida por ley—, **gratuita para el asegurado** y en pilotos medidos. Los representantes de asegurados y pensionistas del Consejo Directivo son garantes.

¿Es gobernar por decreto?

No. Son actos **dentro del marco legal vigente** (la propia Ley de EsSalud), con la Contraloría y SUSALUD vigilando y un tablero público de transparencia. La reforma de fondo —mandato fijo del Presidente Ejecutivo— sí se lleva al Congreso.

¿No hay dinero?

EsSalud cerró 2025 con superávit y grado de inversión. El problema es de **gestión, no de caja**, y la reforma es **neutral para el Tesoro**.

¿Y el personal de salud?

Garantía de no despidos, programa de trato digno y una mesa laboral desde el arranque. Humanizar al que atiende mejora el trato al asegurado.

5 Nota fiscal: de dónde sale cada sol

- EsSalud es **contributivo** (9% del trabajo formal), adscrito al MTPE; no compite por el presupuesto del Tesoro, salvo subsidios puntuales a grupos específicos (p. ej. seguro agrario).
- **Financiamiento de las acciones:** excedente operativo 2025 (flujo de caja +S/ 922 M), recupero de sobrepagos ya detectados por la Contraloría, y ahorros por compra corporativa de medicamentos.
- **Honestidad:** los turnos, el pago por estudio y el leasing tienen costo incremental; se priorizan por rendimiento (más atención por sol), no como gasto nuevo abierto.
- **Reconciliación:** hay superávit hoy, pero el Libro Blanco proyecta un déficit operacional de 31% de los ingresos hacia 2028 si nada cambia. Por eso urge gestionar mejor ahora —no gastar más.

6 Habilitadores críticos (para no sobreprometer)

- **Recursos humanos:** brecha de 18,685; los turnos y la telesalud dependen de especialistas que hoy faltan → incentivos por productividad y redistribución por zona.
- **Interoperabilidad e historia clínica electrónica** (Ley 30024 / RENHICE): precondition del tablero, el intercambio prestacional y la receta electrónica.
- **Atención primaria (APS):** dar capacidad resolutoria al primer nivel es la salida estructural a la pirámide invertida (solo 12 hospitales de alta complejidad en todo el país).
- **Oncología:** estrategia integral (radioterapia, cirugía oncológica, continuidad del tratamiento), más allá de la auditoría de compras.

El éxito se mide en una sola pregunta: **¿el asegurado espera menos y confía más que en 2026?**

“Devolverle a cada trabajador el seguro que ya pagó.”

Documento de respaldo técnico con la matriz legal completa de las 22 acciones, las tablas de datos y las fuentes oficiales, disponible por separado.